

QUEMADURAS DE MANOS, PIES Y GENITALES

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Existen determinadas áreas corporales que, debido a su función especial, su anatomía compleja o incluso a su función cosmética, precisan una atención específica desde el momento inicial.

DIAGNÓSTICO

Quemaduras en manos

Cada mano corresponde aproximadamente a un 2% de superficie corporal. La clave para clasificar correctamente las quemaduras, es la valoración inicial de su profundidad por personal especializado. Aún así, determinarla correctamente en fase aguda es, a veces, tarea difícil. (Ver capítulo de clasificación de quemaduras)

Quemaduras en pies

Cada pie supone aproximadamente un 3% de la superficie corporal. Al igual que en las manos, lo fundamental es determinar la profundidad de la quemadura, aunque en esta localización puede ser más problemático puesto que la piel suele ser más fina, estar más pigmentada a medida que progresa la edad y estar peor vascularizada, sobre todo en ancianos.

Quemaduras en genitales

Esta área supone aproximadamente un 1% de la superficie corporal, dándose este valor en el varón. Suele aparecer en el contexto de quemaduras más severas, aunque los casos delimitados a esta área son más frecuentes en niños, en los que se derrama líquido caliente cuando llevan poca ropa (ej. tratamientos con vahos, comida caliente vertida de forma accidental, etc.). Otros casos más raros pueden ser en quemaduras eléctricas con salida de la corriente por genitales.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Quemaduras en manos

En quemaduras dérmico-superficiales, al inicio deben ser lavadas con suero fisiológico, retirando la piel quemada y procediéndose a la apertura de las flictenas mayores de 1 cm de diámetro. Posteriormente, realizaremos la cura con gasas vaselinadas y, si precisa, añadir antiséptico tópico. De esta manera, la mayoría de las quemaduras dérmicas superficiales, curarán en 2-3 semanas, en régimen ambulatorio.

Quemaduras de mayor o igual profundidad de 2º Grado, deberán ser curadas cada 24 horas con sulfadiacina argéntica. El vendaje debe realizarse individualizando cada dedo y debe permitir la movilización precoz. No se recomienda antibioterapia sistémica de forma rutinaria. La extremidad debe mantenerse elevada para disminuir el edema y así mismo debe pautarse una correcta analgesia. Estas quemaduras podrían precisar tratamiento quirúrgico.

La única urgencia real en quemaduras en manos son aquéllas que puedan producir un síndrome compartimental. En ese caso es necesario ser valoradas por especialista que indique si es preciso o no realizar escarotomías. Los casos en los que están indicadas dichas escarotomías son:

- En quemaduras profundas circunferenciales.
- Con tensión a la palpación.

- Con dolor y resistencia al estiramiento pasivo de los dedos.
- Con disminución del relleno capilar en los pulpejos de los dedos.
- Con pérdida de los pulsos cubitales o radiales, lo cual ocurre en fases avanzadas. El síndrome compartimental puede ocurrir con pulsos presentes.
- En quemaduras eléctricas de alto voltaje. Éstas pueden incluso precisar fasciotomía.

Quemaduras en pies

El manejo es muy similar al de las quemaduras en las manos, tanto en las quemaduras dérmico-superficiales como en las dérmico-profundas. Además, debido a la localización, es más importante la elevación de la pierna puesto que el edema se incrementará con la posición de pie. Esto no quiere decir que se contraindique la deambulación, pero se ha de evitar que el paciente se mantenga mucho tiempo en esta posición.

La valoración de un síndrome compartimental en las quemaduras profundas será la misma que en las manos, requiriendo ser valorado por especialista en caso de sospecha del mismo.

Quemaduras en genitales

El uso de catéteres de sondaje vesical suele ser necesario en la fase aguda, teniendo en cuenta que su uso prolongado, se asocia con mayor incidencia de estenosis uretrales e infecciones urinarias. El manejo que se realizará en las quemaduras superficiales será con gasas vaselinadas asociando antiséptico, evitando los vendajes compresivos en el pene. En caso de ser quemaduras más profundas, la cura ideal es con sulfadiazina argéntica, aunque precisarán valoración por el especialista.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Cavero J, Arévalo-Velasco JM, Lorente JA. Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico. Emergencias. 1999;(11):295-301.
- Manual de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. [Internet]. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. SECPRE [acceso septiembre de 2019]. Disponible: <http://www.secpre.org/documentos%20manual.html>.
- Tredget EE. Management of the acutely burned upper extremity. Hand Clin. 2000;16(2): 187-203.